ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

DERMATOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Psoriasis, Cáncer de Piel & NET



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Dermatología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS					
6.01.1.001	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.002	Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9, Q10, Q11	Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7)
6.01.1.003	Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12, Q13, Q14, Q15, Q16	Tomo 16 · 16.3 (Pág. 9)
6.01.1.008	Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q17, Q18	Tomo 16 · 16.4 (Pág. 11)
6.01.1.011	Fotodermatosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.026	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.028	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 16 · 16.17 (Pág. 56)
6.01.1.032	Vitiligo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.010	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
7.01.1.001	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8	Tomo 16 · 16.1 (Pág. 5)
BLOQUE 2: DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS					
6.01.1.004	Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q30, Q31, Q33, Q34	Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9)
6.01.1.005	Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q32	Tomo 16 · C.8 (Pág. 20)
6.01.1.006	Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27	Tomo 16 · 16.5 (Pág. 16)
6.01.1.007	Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q35, Q36	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.012	Granuloma piogénico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19, Q20	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.024	Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.01.2.002	Ántrax	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 16 · C.16 (Pág. 36)
6.01.2.011	Loxocelismo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	—	Q22, Q23	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
BLOQUE 3: DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS					
6.01.1.002	Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q45, Q46	Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7)
6.01.1.015	Líquen plano	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.025	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.030	Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q47	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.001	Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q48	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.003	Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q40, Q41, Q42, Q43, Q44	Tomo 16 · 16.10 (Pág. 33)
6.01.2.004	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51, Q52, Q53	Tomo 16 · 16.9 (Pág. 29)
6.01.2.006	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.012	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.013	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q54	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
BLOQUE 4: FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES					
1.09.1.006	Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58)
6.01.1.009	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q64	Tomo 16 · C.4 (Pág. 12)
6.01.1.010	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.017	Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.020	Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.023	Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.01.1.031	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.033	Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q72	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.004	Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59, Q60, Q61, Q62	Tomo 16 · 16.9 (Pág. 29)
6.01.2.005	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q67, Q68	Tomo 16 · 16.12 (Pág. 41)
6.01.2.007	Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q56	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.009	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q69	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.014	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q57	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.015	Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
BLOQUE 5: ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS					
1.08.1.001	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77	Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5)
6.01.1.006	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q85, Q86	Tomo 16 · 16.5 (Pág. 16)
6.01.1.013	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q78	Tomo 16 · 16.17 (Pág. 56)
6.01.1.014	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q79	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.016	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80, Q81	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.018	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.019	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q88	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.01.1.021	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.022	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.027	Sarna	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.029	Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q82	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.008	Completo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 16 · 16.18 (Pág. 58)
6.01.2.016	Completo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q75	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.6.002	Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q83, Q84	Tomo 16 · 16.15 (Pág. 52)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Dermatología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 16 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.08.1.001	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77	Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5)
1.09.1.006	Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70	Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58)
6.01.1.001	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.002	Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9, Q10, Q11, Q45, Q46	Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7)
6.01.1.003	Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12, Q13, Q14, Q15, Q16	Tomo 16 · 16.3 (Pág. 9)
6.01.1.004	Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q30, Q31, Q33, Q34	Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9)
6.01.1.005	Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q32	Tomo 16 · C.8 (Pág. 20)
6.01.1.006	Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27, Q85, Q86	Tomo 16 · 16.5 (Pág. 16)
6.01.1.007	Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q35, Q36	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.008	Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q17, Q18	Tomo 16 · 16.4 (Pág. 11)
6.01.1.009	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q64	Tomo 16 · C.4 (Pág. 12)
6.01.1.010	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q65	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.011	Fotodermatosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.012	Granuloma piogénico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19, Q20	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.013	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q78	Tomo 16 · 16.17 (Pág. 56)
6.01.1.014	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q79	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.015	Líquen plano	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q37	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Completo			
6.01.1.016	Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80, Q81	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.017	Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.018	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.019	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q88	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.020	Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.021	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.022	Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.023	Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.024	Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.025	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.026	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.027	Sarna	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.028	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 16 · 16.17 (Pág. 56)
6.01.1.029	Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q82	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.030	Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q47	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.031	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.032	Vitiligo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q2	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Derivar			
6.01.1.033	Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q72	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.001	Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q48	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.002	Ántrax	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 16 · C.16 (Pág. 36)
6.01.2.003	Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q40, Q41, Q42, Q43, Q44	Tomo 16 · 16.10 (Pág. 33)
6.01.2.004	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51, Q52, Q53, Q59, Q60, Q61, Q62	Tomo 16 · 16.9 (Pág. 29)
6.01.2.005	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q67, Q68	Tomo 16 · 16.12 (Pág. 41)
6.01.2.006	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.007	Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q56	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.008	Completo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 16 · 16.18 (Pág. 58)
6.01.2.009	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q69	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.010	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.011	Loxocelismo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	—	Q22, Q23	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.012	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.013	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q54	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.014	Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q57	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.015	Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.016	Completo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q75	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.6.002	Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q83, Q84	Tomo 16 · 16.15 (Pág. 52)
7.01.1.001	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8	Tomo 16 · 16.1 (Pág. 5)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

PREGUNTA 1 6.01.1.011

1. Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades in- feriores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las lesiones empezaron a apare- cer después. Además, dice que hace un año, le había pasado algo similar, luego de an- dar en moto por los cerros. Al examen físico se observan lesiones como las que se mues- tran en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO (la imagen original mostraba ambos muslos y piernas con múltiples le- siones eritemato-violáceas, muchas de ellas con disposición lineal) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fitodermatitis
B) Enfermedad ampollar
C) Urticaria solar
D) Lupus discoide
E) Vasculitis leucocitoclástica

PREGUNTA 2 6.01.1.032

2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Vitiligo · 6.01.1.032] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vitiligo. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 6.01.2.010

3. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.010] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 4 6.01.1.001

4. Un paciente de 17 años consulta por acné. Al examen Fsico se observan múl8ples comedones en cara, pecho y espalda, asociados a pápulas y pústulas abundantes, y presencia de algunos quistes en dichas zonas con cicatrices atróficas. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Peróxido de benzoilo tópico
B) Clindamicina tópica
C) Isotre2noína oral
D) Doxiciclina oral
E) Adapaleno tópico

PREGUNTA 5 6.01.1.026

5. Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con la exposición solar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acné del adulto
B) Rosácea
C) Dermatomiositis
D) Erupción polimorfa solar
E) Lupus cutáneo crónico

PREGUNTA 6 6.01.1.028

6. Una paciente de 24 años presenta una cicatriz en la zona esternal de gran tamaño, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen Fsico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la cirugía inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Cicatriz hipertrófica en fase ac2va
B) Queloide
C) Cuerpo extraño
D) Úlcera de Marjolin
E) Granuloma piógeno

PREGUNTA 7 7.01.1.001

7. Una paciente de 25 años consulta por una erupción cutánea diseminada. El médico describe lesiones circunscritas de contenido líquido claro seroso, de 2 a 3 milímetros de diámetro, agrupadas en racimo sobre una base eritematosa en el labio superior. ¿Cuál es el nombre semiológico exacto de esta lesión elemental primaria?

A) Pústula
B) Vesícula
C) Ampolla
D) Pápula
E) Erosión

PREGUNTA 8 7.01.1.001

8. ¿Cuál es la diferencia semiológica e histológica fundamental entre una erosión y una úlcera cutánea?

A) La erosión compromete solo la epidermis y cura sin dejar cicatriz, mientras que la úlcera compromete la dermis o hipodermis y cura dejando cicatriz
B) La erosión es siempre de origen infeccioso bacteriano y la úlcera es de origen autoinmune
C) La erosión es una lesión primaria y la úlcera es una lesión terciaria
D) La úlcera es indolora mientras que la erosión cursa con dolor lancinante
E) La erosión es mayor a 5 cm y la úlcera es menor a 1 cm

PREGUNTA 9 6.01.1.002

9. Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico, se aprecia una zona sin cabellos, tal como se muestra en la foto: Foto 15 (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/XXXXXXX). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lupus eritematoso cutáneo crónico
B) Alopecia areata
C) Alopecia androgénica
D) Tricotilomanía
E) Tiña capitis

PREGUNTA 10 6.01.1.002

10. Un joven de 16 años presenta acné moderado con abundantes pápulas y pústulas en rostro y tercio superior del tórax. El médico decide iniciar tratamiento con un antibiótico tópico. ¿Cuál es el principio farmacológico obligatorio que debe respetarse para evitar la rápida aparición de cepas resistentes de Cutibacterium acnes?

A) Prescribir clindamicina tópica en monoterapia por al menos 6 meses continuos
B) Combinar siempre el antibiótico tópico con peróxido de benzoilo o un retinoide tópico, evitando la monoterapia
C) Alternar ciprofloxacino tópico y vancomicina en días sucesivos
D) Usar dosis ultrabajas de penicilina tópica en crema
E) Indicar corticoide tópico de alta potencia junto con el antibiótico

PREGUNTA 11 6.01.1.002

11. Una mujer de 22 años con acné nódulo-quístico severo y cicatrizal refractario a múltiples ciclos de doxiciclina oral es evaluada para inicio de isotretinoína oral. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un REQUISITO OBLIGATORIO ABSOLUTO antes y durante la prescripción de este medicamento?

A) Demostrar niveles séricos indetectables de andrógenos suprarrenales
B) Doble método anticonceptivo eficaz, dos pruebas de embarazo negativas previas y monitorización mensual del perfil lipídico y pruebas hepáticas
C) Realizar biopsia cutánea previa de un nódulo activo
D) Indicar tratamiento concomitante con tetraciclinas orales a dosis altas
E) Dieta hipercalórica rica en grasas saturadas para favorecer la absorción

PREGUNTA 12 6.01.1.003

12. Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se ulcera y sangra con facilidad. Al examen físico se aprecia una lesión escamosa, ulcerada, de 2 cm de diámetro. Como antecedente, trabajó por 20 años, como minero, en la región de Tarapacá. El diagnóstico más probable es:

A) Carcinoma espinocelular
B) Carcinoma basocelular
C) Melanoma maligno
D) Granuloma piógeno
E) Queratosis actínica

PREGUNTA 13 6.01.1.003

13. Una mujer de 44 años consulta por un cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por enrojecimiento de mejillas y nariz que empeora al ingerir alimentos calientes o tras exponerse al sol. Al examen físico se constatan telangiectasias centrofaciales y múltiples pápulas y pústulas inflamatorias dispersas sobre ambas mejillas. No se observan comedones abiertos ni cerrados. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea más adecuado?

A) Clobetasol crema al 0.05% cada 12 horas
B) Metronidazol en gel al 0.75% o ivermectina tópica al 1%
C) Adapaleno gel al 0.1% en monoterapia
D) Mupirocina ungüento al 2%
E) Ácido salicílico al 10% en solución alcohólica

PREGUNTA 14 6.01.1.003

14. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico cutáneo permite DESCARTAR con mayor certeza el diagnóstico de rosácea y orientar definitivamente hacia acné vulgar?

A) Presencia de eritema en la región malar
B) Presencia de comedones abiertos ("puntos negros") o cerrados
C) Presencia de pústulas foliculares confluentes
D) Presencia de telangiectasias centrofaciales
E) Empeoramiento de las lesiones con la ingesta de alcohol

PREGUNTA 15 6.01.1.003

15. Una paciente de 84 años consulta por aparición de una lesión en la zona supraciliar izquierda, hace 12 meses, pruriginosa, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se observa lo siguiente: FOTO (Mujer adulta mayor con lesión ulcerada en la zona supraciliar, borde eritematoso, de 1 cm de diámetro aprox.). El diagnóstico más probable es:

A) Carcinoma basocelular
B) Queratosis actínica
C) Queratosis seborreica
D) Granuloma piógeno
E) Melanoma acrómico

PREGUNTA 16 6.01.1.003

16. Un paciente de 83 años, calvo, con antecedente de múltiples queratosis actínicas en la cabeza, presenta una lesión en el cuero cabelludo, que notó hace 3 meses y que ha ido creciendo hasta alcanzar un diámetro de 2 x 3 cm. Se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Melanoma
B) Impétigo
C) Dermatitis de contacto
D) Quemadura solar
E) Carcinoma espinocelular

PREGUNTA 17 6.01.1.008

17. Un hombre de 24 años consulta por caída progresiva de cabello en las regiones temporales y en la coronilla desde hace 2 años, con patrón idéntico al de su padre. Al examen se constata retroceso de la línea de implantación frontotemporal y adelgazamiento marcado del cabello en el vértex, observándose pelos muy finos y cortos junto a los orificios foliculares conservados. ¿Cuál es el fármaco oral de elección para frenar la progresión y su mecanismo de acción?

A) Prednisona oral; inmunosupresión de linfocitos T periféricos
B) Finasteride oral; inhibición de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 disminuyendo la síntesis de dihidrotestosterona
C) Ketoconazol oral; inhibición de la síntesis de ergosterol
D) Espironolactona oral en dosis altas
E) Metotrexato oral semanal

PREGUNTA 18 6.01.1.008

18. Una mujer de 30 años consulta muy angustiada porque desde hace 3 semanas se le cae el cabello en forma masiva cada vez que se peina o ducha, encontrando puñados de pelos en la almohada. Refiere que hace 3 meses dio a luz a su primer hijo por cesárea sin incidentes. Al examen físico no se aprecian placas alopécicas circunscritas; el cuero cabelludo es normal y la prueba de tracción ("pull test") es positiva difusa en toda la cabeza, desprendiéndose pelos con bulbo telógeno intacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?

A) Alopecia areata universal incipiente; hospitalizar para pulsos de metilprednisolona
B) Efluvio telógeno agudo puerperal; tranquilizar a la paciente y explicar que el cuadro es transitorio y se recuperará espontáneamente
C) Tiña del cuero cabelludo (Tinea capitis); indicar griseofulvina oral
D) Lupus discoide cutáneo; indicar biopsia en sacabocados urgente
E) Alopecia androgenética femenina severa; indicar finasteride oral inmediato

BLOQUE 2 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

PREGUNTA 19 6.01.1.012

19. Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía: Foto 4 (http://sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com/2013/03/no-todas-las-lesiones-de-la- XXXXXX.html) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Verruga vulgar
B) Granuloma piógeno
C) Molusco contagioso
D) Melanoma amelanótico
E) Carcinoma basocelular

PREGUNTA 20 6.01.1.012

20. Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pioderma gangrenoso
B) Hemangioma infantil
C) Nevo atípico inflamatorio
D) Granuloma telangiectásico
E) Melanoma maligno

PREGUNTA 21 6.01.2.002

21. [URGENCIA: Ántrax · 6.01.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Ántrax. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 22 6.01.2.011

22. Una paciente consulta por aparición de una lesión en el atebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico, se aprecia lo siguiente: FOTO (típica placa livedoide en el antebrazo).

A) Loxsocelismo cutáneo
B) Necrosis grasa
C) Ectima
D) Pioderma gangrenoso
E) Fasceítis necrotizante

PREGUNTA 23 6.01.2.011

23. Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Latrodectus mactans (araña del trigo)
B) Paederus irritans (bicho candela)
C) Miasis cutánea
D) Loxosceles laeta (araña de rincón)
E) Picadura de abeja con reacción local

PREGUNTA 24 6.01.1.006

24. Un hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas bien controlada sufre una herida cortante lineal en el antebrazo izquierdo durante un trabajo de carpintería. Tres semanas después, observa con sorpresa que sobre la cicatriz lineal de la herida se ha desarrollado una placa eritematosa idéntica a sus lesiones de psoriasis, cubierta de escamas plateadas nacaradas. ¿Cómo se denomina este fenómeno semiológico?

A) Signo de Darier
B) Fenómeno isomórfico de Koebner
C) Signo de Nikolsky
D) Fenómeno de patergia
E) Signo de Auspitz

PREGUNTA 25 6.01.1.006

25. Un escolar de 10 años, que presentó una faringoamigdalitis purulenta tratada con paracetamol hace dos semanas, es traído por su madre por la aparición súbita y eruptiva de múltiples pápulas eritematosas pequeñas de 3 a 5 mm, cubiertas por una fina escama blanquecina, diseminadas en todo el tronco y raíz de extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pitiriasis rosada de Gibert
B) Psoriasis en gotas (guttata)
C) Exantema súbito por herpesvirus 6
D) Sífilis secundaria (roseola sifilítica)
E) Escabiosis complicada

PREGUNTA 26 6.01.1.006

26. ¿Cuál de los siguientes tratamientos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en un paciente con psoriasis vulgar debido al altísimo riesgo de desencadenar un rebote potencialmente mortal hacia psoriasis pustulosa generalizada o eritrodermia al suspenderlo?

A) Calcipotriol tópico en ungüento
B) Corticoides orales o sistémicos (como prednisona o betametasona parenteral)
C) Metotrexato oral semanal con suplemento de ácido fólico
D) Fototerapia con radiación ultravioleta B de banda estrecha
E) Anticuerpos monoclonales anti-interleucina 17 (secukinumab)

PREGUNTA 27 6.01.1.006

27. Un hombre de 45 años con psoriasis en placas severa que compromete el 25% de su superficie corporal consulta además por dolor e inflamación tumefacta marcada en el segundo dedo de la mano derecha y en el tercer dedo del pie izquierdo, los cuales lucen completamente engrosados y tumefactos en toda su longitud, semejando un embutido. El factor reumatoide es negativo y la radiografía muestra erosiones en las articulaciones interfalángicas distales. ¿Cómo se denomina este signo inflamatorio característico?

A) Nódulos de Heberden
B) Dactilitis o "dedo en salchicha"
C) Tofos gotosos periarticulares
D) Tenosinovitis infecciosa flexora
E) Eritema nudoso digital

PREGUNTA 28 6.01.1.024

28. Mujer de 35 años con placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas en rodillas y codos, con fenómeno de Auspitz positivo. Compromete el 10% de la superficie corporal. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Psoriasis en placas
B) Dermatitis atópica
C) Dermatitis de contacto
D) Liquen plano
E) Micosis fungoide

PREGUNTA 29 6.01.1.024

29. **Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:**

A) Dermatittis de contacto
B) Psoriasis vulgar
C) Tiña corporis
D) Pitiriasis rosada de Gibert
E) Dermatitis atópica

PREGUNTA 30 6.01.1.004

30. **Un lactante de 8 meses presenta lesiones eccematosas eritematosas, exudativas y muy pruriginosas en ambas mejillas y caras de extensión de los miembros inferiores desde hace 2 meses. Al retirar el pañal, la piel de la zona genitoinguinal y perianal se encuentra perfectamente íntegra y sin eritema ni descamación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Dermatitis del pañal candidiásica
B) Dermatitis atópica del lactante
C) Psoriasis vulgar infantil
D) Dermatitis seborreica del lactante
E) Acrodermatitis enteropática

PREGUNTA 31 6.01.1.004

31. **Un niño de 5 años con antecedentes de dermatitis atópica severa presenta bruscamente un empeoramiento clínico con fiebre de 38.9 °C, malestar general y la aparición de múltiples vesículas umbilicadas agrupadas y pústulas dolorosas que rápidamente se erosionan formando costras en sacabocados sobre las áreas de eccema en cuello y flexuras. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación y el tratamiento específico de urgencia?**

A) Impétigo ampollar; indicar cefadroxilo oral
B) Eccema herpético de Kaposi (erupción variceliforme); hospitalizar e iniciar aciclovir endovenoso
C) Sepsis por Pseudomonas; iniciar ceftazidima endovenosa
D) Reacción adversa a corticoides tópicos; suspender todo tratamiento y observar
E) Molusco contagioso diseminado; realizar curetaje de las lesiones

PREGUNTA 32 6.01.1.005

32. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Dermatitis del pañal · 6.01.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Dermatitis del pañal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 33 6.01.1.004

33. **Un trabajador de la construcción de 40 años consulta por eccema subagudo en ambas manos de 2 meses de evolución. Trabaja preparando mezclas de cemento y albañilería. Refiere prurito intenso que se extiende desde las palmas hacia el dorso de las manos y antebrazos. Se sospecha una dermatitis de contacto alérgica ocupacional. ¿Cuál es el alérgeno presente en el cemento más probablemente responsable del cuadro y el examen para confirmarlo?**

A) Níquel; determinación de IgE específica sérica
B) Dicromato de potasio (cromo); pruebas epicutáneas del parche (Patch test)
C) Látex; prueba de provocación bronquial
D) Resina epoxi; biopsia cutánea por congelación
E) Formaldehído; frotis directo con hidróxido de potasio

PREGUNTA 34 6.01.1.004

34. **Un hombre de 34 años consulta por eritema marcado y descamación grasosa amarillenta muy abundante que compromete de forma simétrica los surcos nasogenianos, el entrecejo y las regiones malares, con brotes intensos en el cuero cabelludo desde hace 3 meses, resistente a cremas hidratantes. Se observa además adelgazamiento moderado y una candidiasis oral al examen bucal. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de mayor prioridad clínica que debe plantear el médico?**

A) Solicitar perfil lipídico y curva de tolerancia a la glucosa para descartar síndrome metabólico
B) Solicitar prueba de ELISA para VIH con consentimiento informado
C) Realizar biopsia de cuero cabelludo para descartar lupus discoide
D) Indicar tratamiento con isotretinoína oral a dosis plenas
E) Prescribir antibióticos orales de amplio espectro por 6 meses

PREGUNTA 35 6.01.1.007

35. **Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:**

A) Celulitis
B) Erisipela
C) Dermatitis de contacto alérgica
D) Dermatitis de contacto irritativa
E) Piodermitis superficial

PREGUNTA 36 6.01.1.007

36. **Un paciente de 83 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, institucionalizado, presenta lesiones en las piernas, de 4 meses de evolución, que se muestran a continuación (www.mdsaude.com): ¿Cuál es el la conducta más adecuada?**

A) Mupirocina tópica
B) Flucloxacilina oral
C) Vendas elásticas
D) Biopsiar las lesiones
E) Vaselina más betametasona tópica

BLOQUE 3 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

PREGUNTA 37 6.01.1.015

37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Líquen plano · 6.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Líquen plano. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 6.01.2.006

38. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.006] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 39 6.01.2.012

39. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 40 6.01.2.003

40. Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes difusos, con aumento de la temperatura local. ¿Cuál es la conducta de elección?

A) Indicar mupirocina tópica

B) Realizar curación con suero fisiológico y control en 48 horas

C) Realizar curaciones diarias con suero fisiológico y povidona yodada

D) Indicar amoxicilina oral por 7 días

E) Indicar cefadroxilo oral por 7 días

PREGUNTA 41 6.01.2.003

41. Un hombre de 55 años inició tratamiento con alopurinol 300 mg/día hace un mes por gota tofácea. Consulta por fiebre de 39 °C, malestar general y un exantema eritematoso difuso confluente en tronco y extremidades, acompañado de evidente edema periorbitario y en mejillas. Al examen no se observan ampollas ni desprendimiento cutáneo. En el hemograma destaca leucocitosis de 16.000/uL con 2.100 eosinófilos/uL y linfocitos atípicos. El perfil hepático muestra GOT 280 U/L y GPT 340 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson

B) Síndrome DRESS

C) Psoriasis eritrodérmica

D) Urticaria aguda alérgica

E) Enfermedad del suero

PREGUNTA 42 6.01.2.003

42. ¿Cuál es el período de latencia típico característico que transcurre entre el inicio del medicamento causal y la aparición de las manifestaciones clínicas del Síndrome DRESS?

A) Menos de 24 a 48 horas
B) De 3 a 5 días
C) De 2 a 8 semanas
D) De 6 a 12 meses
E) Más de 2 años de uso ininterrumpido

PREGUNTA 43 6.01.2.003

43. ¿Cuál es el órgano interno que se compromete con mayor frecuencia en los pacientes con Síndrome DRESS y cuya afectación condiciona la principal causa de mortalidad?

A) Riñón (glomerulonefritis membranosa)
B) Hígado (hepatitis tóxica / necrosis hepática)
C) Pulmón (derrame pleural hemorrágico)
D) Páncreas (pancreatitis aguda necrotizante)
E) Sistema nervioso central (meningoencefalitis aséptica)

PREGUNTA 44 6.01.2.003

44. Una mujer de 32 años es diagnosticada de Síndrome DRESS secundario a fenitoína con compromiso hepático moderado (GPT 380 U/L). Se suspende el fármaco culpable y se inicia prednisona oral a 1 mg/kg/día con excelente mejoría clínica y paraclínica a las dos semanas. Respecto al plan de retiro de la corticoterapia, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender de inmediato la prednisona ya que los exámenes se han normalizado
B) Reducir la dosis rápidamente para suspenderla en un plazo de 3 a 5 días
C) Disminuir la dosis de prednisona de manera muy lenta y progresiva a lo largo de 2 a 3 meses
D) Mantener la dosis plena de 1 mg/kg/día de por vida para evitar reactivación de la epilepsia
E) Cambiar a hidrocortisona tópica en crema y suspender la vía oral

PREGUNTA 45 6.01.1.002

45. Un hombre de 28 años presenta ronchas eritematosas pruriginosas diseminadas en el cuerpo desde hace 2 meses. El médico sospecha una urticaria crónica espontánea. Para corroborar el diagnóstico clínico antes de solicitar exámenes, ¿cuál es la pregunta semiológica clave que debe formularse respecto a las lesiones?

A) ¿Cada roncha individual dura más de 72 horas en el mismo sitio?
B) ¿Las ronchas desaparecen en menos de 24 horas sin dejar marca, apareciendo otras en sitios distintos?
C) ¿Las lesiones dejan cicatrices atróficas deprimidas al desaparecer?
D) ¿Aparecen ampollas de contenido purulento en el centro de las ronchas?
E) ¿Las ronchas duelen intensamente al tacto sin producir picazón?

PREGUNTA 46 6.01.1.002

46. Una paciente de 35 años con diagnóstico de urticaria crónica espontánea continúa presentando brotes diarios de habones intensamente pruriginosos a pesar de tomar religiosamente cetirizina 10 mg al día durante el último mes. No tiene signos de angioedema ni compromiso respiratorio. Según las guías internacionales de manejo de urticaria, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico recomendado?

A) Iniciar prednisona oral 40 mg al día durante 3 meses continuos
B) Aumentar la dosis del antihistamínico H1 de segunda generación hasta cuatro veces la dosis estándar (cetirizina hasta 40 mg/día)
C) Cambiar a clorfenamina oral 4 mg cada 6 horas
D) Iniciar tratamiento con azatioprina oral
E) Indicar plasmaféresis de urgencia

PREGUNTA 47 6.01.1.030

47. Mujer de 28 años con urticaria generalizada de 48h de evolución, prurito intenso. Sin angioedema ni compromiso hemodinámico. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Levocetirizina oral
B) Adrenalina subcutánea
C) Metilprednisolona EV
D) Omalizumab subcutáneo
E) Inmunoterapia sublingual

PREGUNTA 48 6.01.2.001

48. [URGENCIA: Angioedema de Quinque · 6.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Angioedema de Quinque. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 49 6.01.1.025

49. **Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. La inspección facial muestra lo siguiente (fuente: prontopele.com.br): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

PREGUNTA 50 6.01.2.004

50. **Una mujer de 38 años consulta en urgencias por un cuadro febril de 48 horas de evolución acompañado de odinofagia intensa y ardor ocular. Al examen físico presenta lesiones eritematosas en diana atípica en tronco, con flictenas y desprendimiento de la piel que compromete aproximadamente el 7% de la superficie corporal total, asociado a úlceras orales con costras hemáticas labiales y conjuntivitis bilateral. Al realizar una suave presión tangencial con el dedo sobre la piel eritematosa, la epidermis se desliza y desprende. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el signo semiológico descrito?**

A) Eritema multiforme menor y Signo de Darier
B) Síndrome de Stevens-Johnson y Signo de Nikolsky
C) Necrólisis epidérmica tóxica y Fenómeno de Koebner
D) Penfigoide ampollar y Signo de Auspitz
E) Síndrome DRESS y Fenómeno de Patergia

PREGUNTA 51 6.01.2.004

51. **¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida que define y distingue formalmente a la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) del Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)?**

A) Mayor al 5% de superficie corporal total
B) Mayor al 10% de superficie corporal total
C) Mayor al 20% de superficie corporal total
D) Mayor al 30% de superficie corporal total
E) Mayor al 50% de superficie corporal total

PREGUNTA 52 6.01.2.004

52. **Un hombre de 62 años es hospitalizado por una Necrólisis Epidérmica Tóxica que compromete el 45% de la superficie corporal tras iniciar carbamazepina hace dos semanas. Al ingreso a la unidad de pacientes críticos se calculan los parámetros de la escala pronóstica SCORTEN. ¿Cuál de los siguientes hallazgos aporta UN PUNTO de gravedad en dicha escala?**

A) Frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto
B) Edad de 35 años
C) Bicarbonato sérico de 16 mEq/L
D) Glicemia en ayunas de 140 mg/dL
E) Nitrógeno ureico en sangre (BUN) de 15 mg/dL

PREGUNTA 53 6.01.2.004

53. **En el manejo hospitalario de un paciente diagnosticado con Necrólisis Epidérmica Tóxica severa en un Centro de Quemados, ¿cuál de las siguientes intervenciones representa una MALA PRÁCTICA contraindicada?**

A) Mantener la temperatura ambiental de la sala entre 30 °C y 32 °C
B) Desbridamiento quirúrgico agresivo en pabellón de toda la epidermis desprendida y flictenas
C) Instilación frecuente de lágrimas artificiales sin preservantes y evaluación diaria por oftalmología
D) Reposición hídrica intravenosa guiada por diuresis horaria estricta
E) Suspensión inmediata de todos los fármacos no vitales introducidos en las semanas previas

PREGUNTA 54 6.01.2.013

54. **Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:**

A) Psoriasis eritrodérmica
B) Escarlatina quirúrgica
C) Pustulosis exantemática
D) Necrosis epidermolítica tóxica
E) Pénfigo

BLOQUE 4 FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

PREGUNTA 55 6.01.1.023

55. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos · 6.01.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 6.01.2.007

56. [URGENCIA: Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido · 6.01.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 57 6.01.2.014

57. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.014] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 58 6.01.1.020

58. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pénfigo · 6.01.1.020] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pénfigo. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 59 6.01.2.004

59. Un hombre de 76 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas dos semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, ingles y caras internas de muslos. Al examen físico se aprecian numerosas ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas, muy tensas y duras a la palpación, asentadas sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana perilesional, la epidermis no se despega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pénfigo vulgar
B) Penfigoide ampollar
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Dermatitis herpetiforme
E) Epidermólisis bullosa simple

PREGUNTA 60 6.01.2.004

60. ¿Cuál es el hallazgo anatomopatológico característico en la biopsia cutánea que define la ampolla del Pénfigo Vulgar?

A) Ampolla subepidérmica con neutrófilos en las papilas dérmicas
B) Ampolla intraepidérmica suprabasal con acantolisis celular
C) Ampolla subcórnea con pústulas de espongiosis eosinofílica
D) Necrosis de espesor total de la epidermis con despegamiento dermoepidérmico
E) Vacuolización de la capa basal con infiltrado linfocítico en banda

PREGUNTA 61 6.01.2.004

61. Una paciente de 50 años con diagnóstico confirmado de Pénfigo Vulgar extenso inicia tratamiento de inducción. ¿Cuál es el tratamiento médico de primera línea indicado para controlar la actividad de la enfermedad?

A) Corticoides sistémicos a dosis altas (Prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día)
B) Antihistamínicos H1 orales de segunda generación en dosis estándar
C) Dapsona oral combinada con dieta estricta libre de gluten
D) Aciclovir oral en dosis de 800 mg cinco veces al día
E) Metotrexato subcutáneo a dosis bajas en monoterapia exclusiva

PREGUNTA 62 6.01.2.004

62. ¿Cuál es el patrón característico observado en la Inmunofluorescencia Directa (IFD) de una biopsia perilesional en un paciente con Penfigoide Ampollar?

A) Depósito de IgA granular en los vértices de las papilas dérmicas
B) Depósito intercelular intraepidérmico de IgG en patrón de red de pescar
C) Depósito lineal y continuo de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal
D) Ausencia total de depósitos inmunes en la epidermis y dermis
E) Depósito granular de IgM en los vasos capilares dérmicos superficiales

PREGUNTA 63 6.01.2.015

63. [URGENCIA: Pénfigo y penfigoide · 6.01.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pénfigo y penfigoide. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 64 6.01.1.009

64. [ATENCIÓN PRIMARIA: Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin · 6.01.1.009] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 65 6.01.1.010

65. [ATENCIÓN PRIMARIA: Eritema polimorfo menor · 6.01.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Eritema polimorfo menor. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 66 6.01.1.031

66. Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primero ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Queratosis seborreica

B) Melanoma

C) Panadizo

D) Verruga vulgar

E) Cuerpo extraño periungueal

PREGUNTA 67 6.01.2.005

67. Un adulto joven de 24 años consulta por una erupción cutánea en el dorso de ambas manos y antebrazos caracterizada por lesiones redondeadas eritematosas, con un centro purpúrico violáceo rodeado por un anillo pálido edematoso y un halo eritematoso externo (lesiones en diana de 3 anillos). Refiere haber tenido un episodio de herpes labial hace una semana. Al examen físico no se palpan adenopatías y el signo de Nikolsky es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente causal más frecuentemente asociado?

A) Síndrome de Stevens-Johnson por ingesta de paracetamol

B) Eritema multiforme por infección por Virus Herpes Simple

C) Urticaria multiforme por virus de Epstein-Barr

D) Penfigoide ampollar por exposición a radiación UV

E) Lupus eritematoso discoide por fotosensibilidad

PREGUNTA 68 6.01.2.005

68. **Un paciente de 28 años presenta su quinto episodio en el último año de eritema multiforme con lesiones típicas en diana en manos y antebrazos, todos ellos precedidos 10 días antes por un brote visible de herpes labial recurrente. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada para prevenir futuros episodios?**

A) Prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día de forma indefinida
B) Tratamiento profiláctico continuo con Aciclovir oral durante 6 meses
C) Aplicación de protector solar factor 50+ como única medida
D) Inmunoterapia con interferón gamma recombinante subcutáneo
E) Derivación para plasmaféresis de mantención mensual

PREGUNTA 69 6.01.2.009

69. **Adulto mayor con dolor en cuero cabelludo seguido de vesículas en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Aciclovir tópico 5% en crema
B) Famciclovir 500 mg cada 8 horas por 7 días
C) Prednisona oral 40 mg/día por 5 días
D) Gabapentina 300 mg cada 8 horas
E) Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

PREGUNTA 70 1.09.1.006

70. **Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). ¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?**

A) Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta
B) Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo
C) Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética
D) Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión
E) Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

PREGUNTA 71 6.01.1.017

71. **Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al examen físico se observa lo siguiente: Fuente: www.alamy.com El diagnóstico más probable es:**

A) Nevo
B) Melanoma
C) Léntigo
D) Queratosis seborreica
E) Queratosis actínica

PREGUNTA 72 6.01.1.033

72. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Vasculitis cutáneas · 6.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vasculitis cutáneas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

BLOQUE 5 ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

PREGUNTA 73 6.01.1.027

73. **Un paciente de 35 años consulta por intenso prurito en la zona genital de una semana de evolución. Al examen físico, se observan lesiones escrotales, que se muestran en la imagen (fuente: https://rafalafena.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/03/....). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Prúrigo nodular
B) Infección por virus papiloma humano
C) Sífilis primaria
D) Escabiosis
E) Sífilis secundaria

PREGUNTA 74 6.01.2.008

74. **[URGENCIA: Completo · 6.01.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Completo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 75 6.01.2.016

75. [URGENCIA: Completo · 6.01.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Completo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 76 1.08.1.001

76. Un hombre de 68 años presenta en la punta nasal una lesión papular de 6 mm de diámetro, de coloración blanquecina perlada translúcida, de bordes redondeados solevantados, con presencia de finas telangiectasias en su superficie y una úlcera milimétrica en el centro. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Carcinoma basocelular nódulo-ulcerativo
B) Carcinoma espinocelular queratoacantoma
C) Melanoma amelanótico de extensión superficial
D) Queratosis seborreica irritada
E) Lupus eritematoso discoide crónico

PREGUNTA 77 1.08.1.001

77. Una mujer de 72 años consulta por una lesión en el labio inferior que no cicatriza desde hace 6 meses. Al examen se observa una placa de 12 mm, de base indurada e infiltrada, con superficie ulcerada y cubierta de costra hiperqueratósica amarillenta adherente, que sangra al desprendimiento. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Carcinoma basocelular superficial
B) Carcinoma espinocelular infiltrante
C) Herpes labial recidivante crónico
D) Aftosis oral recurrente mayor de Sutton
E) Queilitis angular bacteriana

PREGUNTA 78 6.01.1.013

78. Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

PREGUNTA 79 6.01.1.014

79. Paciente con prurito, aumento grosor uñas en manos y pies, aumento volumen inguinal bilateral, foto de unas manos eritematosas, descamando:

A) Linfoma cutáneo (sd sezary)
B) Sarna noruega
C) Psoriasis
D) Dermatitis crónica
E) Dermatitis atópica

PREGUNTA 80 6.01.1.016

80. Mujer de 35 años con placas eritematosas en cuero cabelludo con alopecia cicatricial, fotosensibilidad y presencia de tapones foliculares. Lesiones similares en mejillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tinea capitis
B) Alopecia androgénica
C) Tricotilomanía
D) Lupus eritematoso discoide
E) Alopecia areata

PREGUNTA 81 6.01.1.016

81. Mujer 30 años con aparición de Placa eritematodescamativa de 2 meses de evolución en pómulo derecho de 3 cm de diámetro y otra similar en cuero cabelludo (zona parietal izquierda) con alopecia central.

A) Lupus cutáneo crónico
B) Dermatitis seborreica
C) Psoriasis
D) Liquen plano
E) Rosácea

PREGUNTA 82 6.01.1.029

82. Un paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, presenta aparición de una lesión en la cara anterior de la pierna derecha, eritematosa y descama8va, que inició hace cerca de 12 meses y ha ido aumentando progresivamente de tamaño. Al examen Fsico se observa la siguiente lesión: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Psoriasis
B) Derma22s de contacto
C) Eccema numular
D) Enfermedad de Bowen
E) Tiña

PREGUNTA 83 6.01.6.002

83. Un hombre de 65 años presenta en la frente y dorso de manos varias máculas eritematosas milimétricas cubiertas por escamas ásperas muy adherentes, que al frotarlas suavemente con el dedo se sienten rugosas como lija. No hay induración ni signos inflamatorios profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Queratosis actínicas
B) Queratosis seborreicas
C) Psoriasis vulgar
D) Lupus eritematoso discoide
E) Linfoma cutáneo de células T

PREGUNTA 84 6.01.6.002

84. ¿Cuál de los siguientes fármacos tópicos está indicado para el tratamiento del "campo de cancerización" en pacientes con múltiples queratosis actínicas faciales?

A) Clobetasol propionato al 0.05% en crema
B) Imiquimod al 5% en crema
C) Mupirocina al 2% en ungüento
D) Ketoconazol al 2% en crema
E) Metronidazol al 0.75% en gel

PREGUNTA 85 6.01.1.006

85. Un escolar de 6 años es traído por su madre por presentar una placa redondeada de 4 cm en el cuero cabelludo, donde el pelo se ha caído parcialmente y los cabellos restantes se observan rotos a pocos milímetros de la superficie cutánea, con descamación superficial asociada y prurito leve. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Ketoconazol en crema al 2% aplicado dos veces al día por 2 semanas
B) Clobetasol tópico al 0.05% por sospecha de alopecia areata
C) Griseofulvina oral a 20 mg/kg/día durante 6 a 8 semanas
D) Permetrina al 1% en loción capilar en dosis única
E) Antibioticoterapia oral con cefadroxilo por 10 días

PREGUNTA 86 6.01.1.006

86. Una mujer de 29 años consulta por intenso prurito nocturno en las manos y cuerpo de 10 días de evolución. Al examen se aprecian lesiones lineales milimétricas y pequeñas pápulas con excoriaciones en los espacios interdigitales de las manos y cara flexora de las muñecas. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es INDISPENSABLE para lograr la erradicación del cuadro?

A) Indicar tratamiento antibiótico oral profiláctico con doxiciclina
B) Tratar simultáneamente a todos los contactos del hogar con permetrina al 5%, presenten o no síntomas
C) Indicar corticoides sistémicos a dosis altas para frenar el prurito de inmediato
D) Aplicar permetrina al 5% exclusivamente sobre las lesiones visibles de las manos
E) Desinfectar los muebles del hogar con soluciones cloradas concentradas

PREGUNTA 87 6.01.1.018

87. Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de Trichophitum rubrum. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Itraconazol
B) Griseofulvina
C) Fluconazol
D) Terbinafina
E) Clotrimazol

PREGUNTA 88 6.01.1.019

88. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pediculosis · 6.01.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pediculosis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 89 6.01.1.021

89. Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras mielicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amoxicilina más ácido clavulánico
B) Macrólidos
C) Betametasona
D) Cefoperazona
E) Ciprofloxacino

PREGUNTA 90 6.01.1.022

90. Una mujer de 18 años presenta una placa eritematosa y levemente pruriginosa, de 5 cm, en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se agregan múltiples lesiones similares, de menor tamaño en todo el tronco. El diagnóstico más probable es:

A) Tiña
B) Lupus cutáneo subagudo
C) Sífilis secundaria
D) Pitiriasis versicolor
E) Pitiriasis rosada

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A Fotodermatosis

6.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Era una fitofotodermatosis por litre (árbol de la zona central chilena).

PREGUNTA 2 Respuesta: A Vitiligo

6.01.1.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vitiligo" (6.01.1.032), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 3 Respuesta: A Inicial

6.01.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.010), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 4 Respuesta: C

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

6.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene un acné nódulo quístico, que se considera de Gpo inflamatorio severo. El acné comedoniano (leve) se trata con re

PREGUNTA 5 Respuesta: B

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

6.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una rosácea clásica: aumenta con la exposición solar. El lupus sistémico también puede afectar las mejillas y aumentar con el sol, pero no tiene tantas pústulas. Además, el lupus cutáneo crónico es una o más placas, sin pústulas, de curso crónico.

PREGUNTA 6 Respuesta: B

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

6.01.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El hecho de sobrepasar los bordes de la herida es lo característico de los queloides. Un porcentaje importante puede tener dolor durante la fase de mayor acGvidad. El cuerpo extraño (ej. reacción a sutura) suele ser más localizado. La úlcera de Marjolin es un cáncer de piel que se origina en quemaduras y cicatrices grandes.

PREGUNTA 7 Respuesta: B

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

7.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Una colección circunscrita de líquido seroso, claro o hemático ubicada en la epidermis, cuyo diámetro es menor a 0.5 centímetros (en este caso 2 a 3 mm), corresponde por definición semiológica estricta a una Vesícula. Las ampollas o flictenas (C) tienen un tamaño mayor a 0.5 o 1 cm. Las pústulas (A) contienen material purulento desde su origen. Las pápulas (D) son lesiones sólidas sin líquido. Las erosiones (E) son lesiones secundarias por pérdida de sustancia. Perla. Colección líquida serosa menor a 0.5 cm es siempre una vesícula.

PREGUNTA 8 **Respuesta: A**

7.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

La diferencia patognomónica entre erosión y úlcera radica en la profundidad anatómica del daño tisular y su capacidad regenerativa. La erosión (o excoriación) es una pérdida de sustancia superficial circunscrita que afecta exclusivamente a la epidermis, respetando la membrana basal; dado que la capa basal de queratinocitos puede regenerar el epitelio por mitosis, la erosión cura restitutio ad integrum SIN DEJAR NINGUNA CICATRIZ. En cambio, la úlcera es una pérdida de sustancia profunda que destruye la membrana basal y penetra hacia la dermis reticular o tejido celular subcutáneo; como la dermis no puede regenerarse mediante mitosis epitelial, el defecto se repara mediante tejido de granulación y síntesis de colágeno fibrótico, dejando SIEMPRE UNA CICATRIZ PERMANENTE. Perla. Erosión = solo epidermis y sin cicatriz; Úlcera = llega a dermis y deja cicatriz.

PREGUNTA 9 **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

Es una alopecia areata clásica.

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

El uso de antibióticos tópicos en monoterapia (como clindamicina al 1% o eritromicina sola) induce de forma extraordinariamente rápida la selección y proliferación de cepas mutantes resistentes de Cutibacterium acnes, perdiendo toda su eficacia clínica en menos de 4 a 8 semanas. Las guías de práctica clínica internacionales y del MINSAL establecen como regla de oro mandatoria que los antibióticos tópicos NUNCA deben prescribirse solos, sino formulados en combinación con Peróxido de Benzoilo (el cual es un agente oxidante queratolítico frente al cual las bacterias no pueden desarrollar resistencia) o con un retinoide tópico. Perla. El antibiótico tópico en acné jamás se da solo: siempre con peróxido de benzoilo.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

La isotretinoína oral es uno de los teratógenos farmacológicos humanos más potentes conocidos, induciendo la embriopatía por retinoides (microtia, anomalías del SNC, defectos cardíacos conotruncales e hidrocefalia en > 30% de los fetos expuestos). Su prescripción en mujeres con potencial de fertilidad exige un programa de prevención de embarazo estricto: dos métodos anticonceptivos complementarios iniciados 1 mes antes de empezar el fármaco, dos pruebas de embarazo negativas previas y test de embarazo mensual durante y hasta 1 mes después del cese del tratamiento. Además, debido a sus efectos sistémicos, se deben controlar basal y periódicamente el perfil lipídico (riesgo de hipertrigliceridemia y pancreatitis) y las transaminasas hepáticas (hepatotoxicidad). Está contraindicado combinar con tetraciclinas (D) por riesgo de pseudotumor cerebri. Perla. Isotretinoína exige doble anticoncepción, test de embarazo y control lipídico/hepático.

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

Es un carcinoma espinocelular clásico, en especial porque se describe como escamosa y ulcerada y tiene antecedente de fotoexposición. Los demás cánceres también se pueden ulcerar. El granuloma piógeno sangra mucho, pero es de aspecto rojo y húmedo.

PREGUNTA 13 **Respuesta: B**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

El cuadro de eritema centrofacial persistente con telangiectasias y pápulo-pústulas en ausencia de comedones en una mujer adulta de 44 años corresponde a una Rosácea Pápulo-pustulosa. El tratamiento tópico de primera línea de elección avalado por la evidencia clínica es el Metronidazol tópico al 0.75% o la Ivermectina tópica al 1% en crema (que actúa contra el ácaro Demodex y reduce la inflamación). El clobetasol (A) es un corticoide ultrapotente que está terminantemente contraindicado en rosácea porque provoca una rosácea esteroidea de rebote catastrófico. El adapaleno (C) es para acné y produciría excesiva irritación en la piel sensible con rosácea. Perla. Metronidazol o ivermectina tópica son la primera línea en rosácea pápulo-pustulosa.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

El criterio semiológico cardinal para el diagnóstico diferencial entre acné vulgar y rosácea es la presencia o ausencia de comedones. El comedón (abierto o cerrado) es la lesión elemental primaria y patognomónica del acné vulgar (originado por la hiperqueratinización infundibular folicular). En cambio, la rosácea es una enfermedad con disregulación vascular e inflamatoria que NUNCA cursa con formación de comedones. Si un paciente presenta pápulas, pústulas y eritema facial pero se constatan comedones al examen físico, el diagnóstico es Acné Vulgar y no Rosácea. Trampa. La rosácea puede tener pápulas, pústulas y eritema idénticos al acné, pero NUNCA comedones.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

Si bien la imagen no era un cáncer basocelular clásico, esa era la única respuesta aceptable.

PREGUNTA 16 **Respuesta: E**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

Tanto por las queratosis actínicas (premalignas, que evolucionan a cáncer espinocelular) como por la imagen, tiene un cáncer espinocelular.

PREGUNTA 17 **Respuesta: B**

6.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno

El cuadro corresponde a una Alopecia Androgenética masculina (calvicie común en patrón de Hamilton-Norwood). Su fisiopatología radica en la acción de la dihidrotestosterona (DHT) sobre receptores androgénicos de folículos susceptibles, provocando su miniaturización progresiva. El fármaco oral de primera línea de elección es el Finasteride (1 mg/día), un inhibidor competitivo selectivo de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, que reduce los niveles tisulares y séricos de DHT en aproximadamente un 70%, deteniendo la caída en más del 85% de los pacientes y estimulando el engrosamiento del cabello miniaturizado. Perla. Finasteride oral inhibe la 5-alfa reductasa y frena la alopecia androgenética.

PREGUNTA 18 **Respuesta: B**

6.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno

El efluvio telógeno agudo (específicamente el efluvio postparto o telogen effluvium) se produce por la caída brusca de los niveles de estrógenos placentarios que mantenían a los cabellos artificialmente en fase de anágeno durante el embarazo. Esto precipita el paso masivo y sincronizado de gran porcentaje de folículos a la fase de telógeno (fase de reposo y caída), manifestándose clínicamente 2 a 3 meses después del parto como una caída difusa y alarmante pero sin pérdida de orificios foliculares ni formación de placas circunscritas. El cuadro es enteramente benigno y autolimitado: el ciclo capilar se normaliza y el cabello se repuebla de forma completa y espontánea en los siguientes 6 meses. La conducta correcta es descartar ferropenia, tranquilizar a la madre y no indicar tratamientos invasivos. Perla. Caída difusa masiva de pelo 2-3 meses postparto es efluvio telógeno fisiológico.

BLOQUE 2 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: B** **Granuloma piogénico**

6.01.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es un granuloma piógeno clásico. Eso sí, la foto era distinta.

PREGUNTA 20 **Respuesta: D** **Granuloma piogénico**

6.01.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Caso clínico oficial EUNACOM para Granuloma piogénico.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A** Ántrax 6.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Ántrax" como urgencia clínica (6.01.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A** Loxocelismo 6.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere

Es un loxsocelismo cutáneo clásico.

PREGUNTA 23 **Respuesta: D** Loxocelismo 6.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere

Loxosceles laeta (araña de rincón)

PREGUNTA 24 **Respuesta: B**

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El desarrollo de lesiones cutáneas características de una dermatosis previa sobre áreas de piel sana que han sufrido un traumatismo físico, mecánico, químico o quirúrgico (como una herida, incisión, quemadura o rascado) se denomina Fenómeno Isomórfico de Koebner. Es un sello semiológico característico de la Psoriasis, del Liquen Plano y del Vitíligo. El signo de Darier (A) ocurre en mastocitosis (habón al frotar). El signo de Nikolsky (C) es el despegamiento epidérmico por presión en pénfigo o NET. La patergia (D) es la formación de una pústula estéril tras un pinchazo en enfermedad de Behçet o pioderma gangrenoso. Perla. Aparición de lesiones sobre cicatriz o trauma es el fenómeno de Koebner.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El brote eruptivo agudo de pápulas descamativas pequeñas ("en gotas de lluvia") en tronco y extremidades en un paciente pediátrico o adolescente, precedido 1 a 2 semanas antes por una infección faringoamigdalina estreptocócica por Streptococcus pyogenes, es la presentación arquetípica de la Psoriasis en Gotas o Guttata. Las toxinas superantigénicas estreptocócicas activan de forma masiva a los linfocitos T cutáneos. Tiene un excelente pronóstico, respondiendo muy bien a la erradicación del estreptococo con antibióticos (amoxicilina) y fototerapia natural o UVB. Perla. Erupción en gotas tras amigdalitis estreptocócica es psoriasis guttata.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Una de las contraindicaciones farmacológicas más universales y estrictas de la dermatología es el uso de corticosteroides por vía sistémica (oral, intramuscular o endovenosa) en pacientes con psoriasis vulgar. Aunque los corticoides orales provocan una mejoría clínica espectacular y rápida durante los primeros días de administración, su reducción o suspensión desencadena invariablemente un fenómeno de rebote severo y catastrófico, induciendo la transformación de la psoriasis vulgar en una Psoriasis Pustulosa Generalizada de von Zumbusch o una Eritrodermia Psoriásica, entidades graves con riesgo de descompensación hemodinámica, hipotermia, sobreinfección bacteriana y muerte. Trampa. NUNCA indicar prednisona oral en un brote de psoriasis vulgar.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La inflamación simultánea y difusa de toda la estructura de un dedo (que involucra las articulaciones interfalángicas, tendones flexores y partes blandas periarticulares), dándole un aspecto tumefacto cilíndrico homogéneo semejante a un embutido, se denomina Dactilitis o "dedo en salchicha". Es un signo patognomónico característico de las espondiloartropatías seronegativas asociadas a HLA-B27, particularmente de la Artritis Psoriásica (afectando a un 30% de estos pacientes). Se acompaña frecuentemente de compromiso de articulaciones interfalángicas distales (IFD), entesitis aquiliana y onicopatía psoriásica. Perla. Dedo en salchicha (dactilitis) en paciente psoriásico confirma artritis psoriásica.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

6.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

Placas eritematosas con escamas plateadas en superficies extensoras + fenómeno de Auspitz (sangrado puntiforme al retirar escama) = psoriasis en placas. Compromiso 10% = psoriasis moderada.

PREGUNTA 29 **Respuesta: B**

6.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

Cuadro clásico

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

El cuadro de lesiones eccematosas exudativas bilaterales intensamente pruriginosas en las mejillas y superficies extensoras de las extremidades en un lactante, con preservación estricta y absoluta de la región cubierta por el pañal, es la presentación semiológica clásica y definitoria de la Dermatitis Atópica en su fase del lactante. La dermatitis del pañal (A) comprometería precisamente el área del pañal. La dermatitis seborreica (D) afecta cuero cabelludo ("costra láctea"), pliegues y área del pañal con escamas untuosas y NO respeta el pañal ni causa prurito tan intenso. La acrodermatitis enteropática (E) por déficit de zinc produce placas erosivas periorificiales y diarrea. Perla. Eccema en mejillas que respeta el pañal es dermatitis atópica del lactante.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

La sobreinfección diseminada por el Virus Herpes Simple (VHS-1 o VHS-2) sobre una piel con dermatitis atópica con barrera epidérmica dañada se denomina Eccema Herpético de Kaposi (o erupción variceliforme de Kaposi). Se caracteriza por un brote agudo y masivo de vesículas umbilicadas agrupadas, dolorosas y confluentes que evolucionan a erosiones en sacabocados con costras hemáticas, acompañadas de fiebre alta y adenopatías. Constituye una verdadera emergencia dermatológica y pediátrica por el alto riesgo de diseminación visceral herpética, queratitis herpética y sobreinfección bacteriana secundaria. Requiere hospitalización urgente y tratamiento antiviral sistémico inmediato con Aciclovir endovenoso. Perla. Niño atópico con brote agudo de vesículas umbilicadas y fiebre tiene eccema herpético (Aciclovir EV).

PREGUNTA 32 **Respuesta: A**

6.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Dermatitis del pañal" (6.01.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

El dicromato de potasio (sales de cromo hexavalente) es el alérgeno clásico presente en el cemento húmedo y constituye la causa profesional más frecuente de dermatitis de contacto alérgica grave e incapacitante en trabajadores de la construcción y albañiles. Dado que es una reacción de hipersensibilidad celular tipo IV mediada por linfocitos T, el método confirmatorio de certeza son las pruebas epicutáneas del parche (Patch test) con lectura a las 48 y 96 horas. El níquel (A) es típico de bisutería. El látex (C) produce hipersensibilidad inmediata tipo I con habones. Perla. Eccema de manos en trabajador de la construcción con cemento es alergia al cromo (dicromato de potasio).

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

La presencia de una Dermatitis Seborreica extensa, atípica, severa y refractaria a tratamiento convencional en un adulto joven, especialmente cuando se acompaña de signos de inmunodepresión celular como candidiasis orofaríngea recurrente o baja de peso, es un marcador clínico centinela de Primoinfección o infección avanzada por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La prevalencia de dermatitis seborreica alcanza entre el 40% y el 80% en pacientes seropositivos, con una severidad que se correlaciona inversamente con el recuento de linfocitos CD4. La conducta médica inmediata e inexcusable en atención primaria es ofrecer y solicitar el test de ELISA para VIH. Perla. Dermatitis seborreica severa o explosiva en adulto joven exige solicitar test de VIH.

PREGUNTA 35 **Respuesta: C**

6.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

Faltaba información y no era posible ver bien la imagen. Podría ser una dermatitis de contacto alérgica, porque era en relación a un aro y excedía la zona de contacto, pero las lesiones en la cara no calzaban del todo. La visualización de costras melicéricas es muy sugerente de impétigo (piodermitis superficial), pero también puede verse en la dermatitis de contacto y el cuadro es clásico de esta enfermedad. No puede ser celulitis, porque no hay tejido celular subcutáneo en la oreja.

PREGUNTA 36 **Respuesta: E**

6.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

Caso clínico oficial EUNACOM para Dermitis de contacto.

BLOQUE 3 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A** **Líquen plano**

6.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Líquen plano" (6.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.006), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 40 **Respuesta: E**

6.01.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

Tiene una celulitis. Se trata con antibióticos orales (solo si no tiene fiebre) o idealmente endovenosos, que cubran S. aureus (cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas de primera generación; en alérgicos a todos los betalactámicos: clindamicina).

PREGUNTA 41 **Respuesta: B**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

El cuadro corresponde con total precisión a un Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) inducido por alopurinol. Presenta todos los elementos diagnósticos clásicos: latencia de 4 semanas (1 mes), fiebre alta persistente, exantema morbiliforme confluente con edema facial prominente (sello semiológico), eosinofilia marcada (> 1.500/uL), linfocitos atípicos en sangre y compromiso hepático evidente con elevación de transaminasas. En el SSJ (A) habría ampollas, desprendimiento epidérmico, Nikolsky positivo y compromiso mucoso hemorrágico severo, sin eosinofilia prominente. La psoriasis eritrodérmica (C) cursa con descamación laminar generalizada y no da hepatitis ni eosinofilia de este grado.

PREGUNTA 42 **Respuesta: C**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

Una de las características más importantes y preguntadas del Síndrome DRESS en el EUNACOM es su período de latencia inusualmente prolongado, que típicamente oscila entre 2 y 8 semanas (promedio 3 a 6 semanas) después de la primera dosis del fármaco responsable. Esto contrasta abiertamente con las reacciones anafilácticas o urticarias inmediatas (minutos a pocas horas), el exantema maculopapular benigno común (4 a 10 días) y el síndrome de Stevens-Johnson (1 a 3 semanas). Esta latencia tardía con frecuencia dificulta el reconocimiento inicial si el médico no indaga fármacos iniciados el mes previo.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

El hígado es, por amplio margen, el órgano interno más frecuentemente comprometido en el Síndrome DRESS, afectándose en el 75% al 90% de todos los casos confirmados. La presentación varía desde una elevación asintomática de transaminasas hasta una hepatitis tóxica severa con ictericia y coagulopatía, siendo la insuficiencia hepática aguda fulminante la principal causa de muerte por este síndrome (mortalidad global del 5% al 10%). El riñón (B) se afecta en un 15-30% de los casos (nefritis tubulointersticial, especialmente por alopurinol), pero con menor frecuencia que el hígado.

PREGUNTA 44 **Respuesta: C**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

En el síndrome DRESS, el desescalamiento de la corticoterapia sistémica debe realizarse de forma extraordinariamente lenta y paulatina, a lo largo de 8 a 12 semanas (2 a 3 meses). Esto se debe a que la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T y la reactivación concomitante del herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) persisten activas mucho después de retirado el medicamento. Una suspensión rápida (en días o semanas cortas) provoca casi invariablemente un "efecto rebote" con recurrencia de la fiebre, reaparición del exantema y hepatitis fulminante grave. Mantenerla de por vida (D) es incorrecto y tóxico.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

La propiedad semiológica definitoria y sine qua non del habón de la urticaria es su carácter evanescente o fugaz: debido a que el edema vasomotor de la dermis papilar se reabsorbe con rapidez, cada lesión individual tiene una duración efímera, desapareciendo por completo en menos de 24 horas sin dejar ninguna mancha, hematoma ni cicatriz en la piel afectada, mientras brotan nuevas lesiones en otras localizaciones anatómicas. Si la lesión permanece fija por más de 24-48 horas o deja una pigmentación purpúrica hemosiderótica al resolverse (A, C, E), orienta a una vasculitis urticariana. Perla. El habón de la urticaria dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar rastro.

PREGUNTA 46 **Respuesta: B**

Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El algoritmo internacional estandarizado de las guías EAACI/GA²LEN/EDF/WAO para el tratamiento de la urticaria crónica refractaria establece claramente que, ante el fracaso terapéutico de un antihistamínico H1 de segunda generación a dosis estándar transcurridas 2 a 4 semanas, el segundo escalón mandatorio es incrementar la dosis del mismo antihistamínico H1 de segunda generación hasta dos, tres o cuatro veces la dosis habitual (hasta 4 veces la dosis convencional, ej. cetirizina 40 mg/día o levocetirizina 20 mg/día). Esta estrategia logra el control en más del 60-70% de los pacientes refractarios con un excelente perfil de seguridad. Los corticoides orales a largo plazo (A) están contraindicados. Los antihistamínicos de primera generación como clorfenamina (C) ya no se recomiendan por sus efectos sedantes y anticolinérgicos. Perla. En urticaria refractaria a dosis estándar, se cuadruplica el antihistamínico de 2.ª generación.

PREGUNTA 47 **Respuesta: A**

Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

6.01.1.030 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Urticaria aguda sin anafilaxia: antihistamínicos H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, loratadina) son primera línea. Corticoides se reservan para casos refractarios.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

6.01.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Angioedema de Quinque" como urgencia clínica (6.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 49 **Respuesta: A**

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

6.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico presentado, junto con la imagen, son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

PREGUNTA 50 **Respuesta: B**

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro corresponde a un Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y el signo semiológico descrito es el Signo de Nikolsky positivo. El SSJ se define por el desprendimiento epidérmico en menos del 10% de la superficie corporal total con compromiso severo de al menos dos mucosas (oral y ocular en este caso). El Signo de Nikolsky consiste en el despegamiento o desprendimiento de la epidermis al aplicar una suave fricción tangencial sobre la piel eritematosa o perilesional, lo que traduce necrosis epidérmica aguda o acantolisis. Si el compromiso fuera > 30% sería NET (C). El eritema multiforme menor (A) respeta mucosas o afecta una sola de forma leve y Nikolsky es negativo. Auspitz (D) es rocío sangrante en psoriasis.

PREGUNTA 51 **Respuesta: D**

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La clasificación internacional del consenso dermatológico estratifica el espectro SSJ/NET según el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida con necrosis epidérmica de espesor total: 1) Síndrome de Stevens-Johnson: afectación menor al 10% de la BSA; 2) Síndrome de Superposición SSJ/NET: afectación entre 10% y 30% de la BSA; 3) Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Síndrome de Lyell): desprendimiento en más del 30% de la BSA. Recordar: corte menor al 10% es SSJ, corte mayor al 30% es NET.

PREGUNTA 52 **Respuesta: C**

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El score pronóstico SCORTEN consta de 7 variables evaluadas al ingreso (1 punto cada una): 1) Edad ≥ 40 años; 2) FC ≥ 120 lpm; 3) Neoplasia activa; 4) Superficie epidérmica desprendida inicial > 10%; 5) BUN > 28 mg/dL (> 10 mmol/L); 6) Bicarbonato sérico < 20 mEq/L; 7) Glicemia > 252 mg/dL (> 14 mmol/L). En este paciente, el bicarbonato de 16 mEq/L es menor a 20 mEq/L, por lo que suma un punto de gravedad. La edad de 35 años no suma punto (el corte es ≥ 40 años), la FC de 95 lpm no suma punto (el corte es ≥ 120 lpm), la glicemia de 140 mg/dL no suma (corte > 252 mg/dL) y el BUN de 15 mg/dL tampoco suma (corte > 28 mg/dL).

PREGUNTA 53 **Respuesta: B**

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A diferencia de las quemaduras térmicas profundas de tercer grado, en la Necrólisis Epidérmica Tóxica el desbridamiento quirúrgico agresivo de la epidermis desprendida está CONTRAINDICADO. La epidermis necrótica desprendida actúa como un apósito biológico natural que protege la dermis papilar subyacente y favorece la reepitelización sin cicatriz profunda si no se somete a tracción traumática. Las ampollas grandes pueden aspirarse con aguja estéril preservando el techo de la flictena y cubriendo con gasas no adherentes. El ambiente térmico cálido (A), la protección ocular intensiva para prevenir simbléfaron (C), la fluidoterapia controlada (D) y el retiro farmacológico precoz (E) son pilares fundamentales de la buena práctica médica.

PREGUNTA 54 **Respuesta: D**

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

6.01.2.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una NET clásica, con el signo de Kikolski (se desprende la epidermis), aunque no era la imagen más característica de la NET.

BLOQUE 4 FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A**

Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos

6.01.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos" (6.01.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A**

Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido

6.01.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido" como urgencia clínica (6.01.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.014), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A**

6.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pénfigo" (6.01.1.020), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

El cuadro clínico es patognomónico de Penfigoide Ampollar. Los hallazgos cardinales que lo confirman son: 1) Edad avanzada (76 años con patología neurológica crónica asociada); 2) Prurito intenso prodrómico; 3) Ampollas tensas, de paredes gruesas y resistentes que no se rompen fácilmente; 4) Signo de Nikolsky negativo (la epidermis sana no se desprende con la fricción); y 5) Ausencia de compromiso en la mucosa oral. El pénfigo vulgar (A) afectaría a personas más jóvenes (40-60 años), cursaría con ampollas flácidas muy frágiles, Nikolsky positivo y compromiso oral casi universal. La NET (C) es una farmacodermia aguda grave con Nikolsky positivo y desprendimiento masivo. La dermatitis herpetiforme (D) se asocia a celiaquía con vesículas en codos y rodillas.

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

El hallazgo histopatológico diagnóstico del Pénfigo Vulgar es la ampolla intraepidérmica de localización suprabasal con acantolisis (pérdida de uniones desmosómicas entre queratinocitos mediada por anticuerpos anti-desmogleína 3). La hilera de queratinocitos de la capa basal permanece adherida a la membrana basal mediante sus hemidesmosomas indemnes, adoptando el clásico aspecto de "hilera de lápidas sepulcrales". La ampolla subepidérmica (A) es propia del penfigoide ampollar y dermatitis herpetiforme. La ampolla subcórnea (C) es del impétigo ampollar o pénfigo foliáceo. La necrosis epidérmica total (D) es de la NET. La vacuolización basal en banda (E) es del liquen plano.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

El pilar fundamental e irremplazable de primera línea para el tratamiento del Pénfigo Vulgar agudo son los Corticoides Sistémicos en dosis altas (Prednisona oral a 1.0 a 1.5 mg/kg/día, o pulsos endovenosos de metilprednisolona en formas hiperagudas fulminantes). Debido a la alta morbimortalidad de los corticoides a largo plazo, se asocian precozmente a agentes biológicos como Rituximab (anti-CD20) o inmunosupresores como azatioprina o micofenolato como ahorradores de corticoides. La dapsona con dieta sin gluten (C) es el tratamiento de la dermatitis herpetiforme asociada a celiaquía. El aciclovir (D) trata herpes. Los antihistamínicos (B) no frenan la acantolisis autoinmune.

PREGUNTA 62 **Respuesta: C**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

En el Penfigoide Ampollar, la inmunofluorescencia directa (IFD) sobre piel perilesional revela un depósito continuo y lineal de IgG y factor C3 del complemento a lo largo de la zona de la membrana basal (unión dermoepidérmica), donde se ubican los antígenos hemidesmosómicos BP180 y BP230. En contraste, el pénfigo vulgar (B) muestra un depósito intercelular de IgG en patrón de "red de pescar" o "malla" en la epidermis. El depósito granular de IgA en las papilas dérmicas (A) es patognomónico de la dermatitis herpetiforme de Duhring-Brocq.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A**

6.01.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pénfigo y penfigoide" como urgencia clínica (6.01.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A**

6.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin" (6.01.1.009), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 65 **Respuesta: A**

6.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Eritema polimorfo menor" (6.01.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 66 **Respuesta: D**

6.01.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

Es una verruga paraungueal clásica. La descripción era muy clara. La imagen era algo más confundente.

PREGUNTA 67 **Respuesta: B**

6.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

La presencia de lesiones en diana o escarapela típica con 3 anillos concéntricos en extremidades acrales, asociadas al antecedente inmediato de herpes labial (7 a 14 días previos), es el cuadro clásico indiscutible de un Eritema Multiforme inducido por Virus Herpes Simple (VHS). El VHS es el responsable de más del 70% de todos los casos de eritema multiforme. El SSJ (A) cursa con dianas atípicas de solo dos zonas, Nikolsky positivo, flictenas con desprendimiento epidérmico y compromiso mucoso severo. La urticaria multiforme (C) produce habones evanescentes migratorios que duran menos de 24 horas cada uno. El penfigoide (D) da ampollas tensas en ancianos.

PREGUNTA 68 **Respuesta: B**

6.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

En pacientes con Eritema Multiforme recurrente frecuente (más de 3 a 5 episodios al año) asociado a reactivaciones documentadas de Virus Herpes Simple (VHS), la indicación médica con mayor nivel de evidencia es la profilaxis o terapia supresiva continua con antivirales orales: Aciclovir oral (400 mg cada 12 horas) o Valaciclovir (500 mg una vez al día) durante 6 a 12 meses. Esta estrategia suprime la replicación del ADN viral del VHS en los ganglios sensitivos, previniendo el estímulo inmunológico antigénico en la piel y evitando las recidivas en más del 80% de los casos. Los corticoides sistémicos continuos (A) están contraindicados por su severa toxicidad acumulativa.

PREGUNTA 69 **Respuesta: E**

6.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

PREGUNTA 70 **Respuesta: B**

1.09.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo. Esta técnica permite la extirpación diagnóstica íntegra y asegura la medición histológica fidedigna del espesor de Breslow, sin desestructurar la arquitectura de la lesión.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

6.01.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un melanoma clásico, tanto por la edad, como por el crecimiento. La imagen sí tiene un aspecto de queratosis seborreica, aunque el halo hiperpigmentado y la lesión satélite son más de melanoma.

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

6.01.1.033 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vasculitis cutáneas" (6.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

BLOQUE 5 ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: D** Sarna

6.01.1.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sarna Nodular: La presencia de prurito en la zona genital puede ser compatible con escabiosis (sarna) o infestación por ladillas (Phthirus pubis). Sin embargo, si las imágenes muestran lesiones nodulares características, se confirma el diagnóstico de sarna nodular.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** Completo

6.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Completo" como urgencia clínica (6.01.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 75 **Respuesta: A** Completo

6.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Completo" como urgencia clínica (6.01.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 76 **Respuesta: A**

Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La tríada semiológica de pápula translúcida con brillo perlado, telangiectasias arboriformes superficiales y ulceración central ("úlcera de Rodent") en una zona fotoexpuesta facial (nariz) es patognomónica del Carcinoma Basocelular, el tumor maligno cutáneo más frecuente.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Toda úlcera o placa costrosa indurada en el labio inferior que no cicatriza en más de 2 a 4 semanas debe considerarse un Carcinoma Espinocelular (CEC) hasta demostrar lo contrario. El labio inferior es una localización de alto riesgo para CEC (precedido comúnmente por queilitis actínica) y tiene un riesgo significativo de metástasis a ganglios submentonianos y submandibulares.

PREGUNTA 78 **Respuesta: A**

Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

6.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles (≥5) obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

PREGUNTA 79 **Respuesta: A**

Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

6.01.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 113). Evalúa el manejo clínico de Linfomas cutáneos según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 80 **Respuesta: D**

Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

6.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Lupus discoide: placas eritematosas con escamas adherentes, tapones foliculares y alopecia cicatricial en cuero cabelludo + fotosensibilidad en mejillas. Alopecia cicatricial permanente. Tratamiento: antipalúdicos (cloroquina) + protección solar.

PREGUNTA 81 **Respuesta: A**

Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

6.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide).

PREGUNTA 82 **Respuesta: D**

Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

6.01.1.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Si bien por la ubicación y aspecto se podía pensar en una psoriasis, la edad, la evolución y la presencia de una única lesión es característica de la enfermedad de Bowen, que es un cáncer espinocelular in situ. Fuente imagen: hxps://iqb.es/dermatologia.

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

6.01.6.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Las máculas eritematosas poco delimitadas con escamas adherentes ásperas al tacto (signo de la lija) en zonas fotoexpuestas crónicas son patognomónicas de las Queratosis Actínicas, lesiones premalignas inducidas por daño solar ultravioleta acumulativo.

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

6.01.6.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El Imiquimod al 5% en crema es un inmunomodulador tópico aprobado y ampliamente utilizado para tratar el campo de cancerización en queratosis actínicas múltiples, ya que estimula la respuesta inmune innata y adaptativa local eliminando queratinocitos atípicos subclínicos en toda el área fotoexpuesta.

PREGUNTA 85 **Respuesta: C**

Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde a una Tiña de la Cabeza (Tinea capitis), producida comúnmente por Microsporum canis. La regla de oro en dermatología pediátrica es que la tiña capitis requiere SIEMPRE tratamiento antimicótico por vía oral (Griseofulvina oral durante 6 a 8 semanas, administrada idealmente con alimentos grasos para mejorar su absorción), ya que los antimicóticos tópicos no logran penetrar la raíz del folículo piloso afectado.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En la escabiosis, el pilar más crítico para evitar el fracaso terapéutico y las reinfecciones continuas en "ping-pong" es tratar de forma simultánea a TODOS los convivientes y contactos estrechos del paciente con permetrina al 5% en crema (o ivermectina oral), independientemente de si presentan síntomas clínicos o no, ya que el período de incubación asintomático puede durar hasta 4 a 6 semanas.

PREGUNTA 87 **Respuesta: D**

Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

6.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La terbinafina oral es el tratamiento de elección de la onicomicosis.

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

6.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pediculosis" (6.01.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

6.01.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un impétigo. Cloxacilina o cefadroxilo habrían sido de elección, pero la amoxicilina más ácido clavulánico cubren bien al S. Aureus y al S. Pyogenes, que son los agentes etiológicos.

PREGUNTA 90 **Respuesta: E**

Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

6.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pitiriasis rosada de Gibert clásica, con la mancha heráldica y la posterior aparición del exantema rosado y descamativo. Puede o no tener prurito.
